Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

3VARCIVBSB
3ª Vara Cível de Brasília

Número do processo: 0737805-34.2024.8.07.0001
Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LAVINIA MARIA MAIA DE LEMOS
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ALDEIR MAIA TEIXEIRA
REU: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

SENTENÇA

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por **LAVÍNIA MARIA MAIA DE LEMOS**, representada por MARIA ALDEIR MAIA TEIXEIRA, em desfavor de **GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE**, partes qualificadas nos autos.

Narra a inicial que a autora é beneficiária do plano de saúde operado pela ré desde 2019 e foi diagnosticada com esclerose múltipla progressiva secundária em 1999.

Informa que a paciente fez uso de diversos medicamentos, incluindo imunomoduladores e corticoides, contudo, o quadro clínico vem se agravando, com novos surtos e aumento das lesões cerebrais.

Descreve que a médica responsável prescreveu o medicamento Kiendra (Siponimode), sendo, contudo, negada a autorização para o custeio pela ré, por não constar no rol da ANS.

Relata que a autora arcou com as primeiras doses do medicamento, no montante de R$ 36.851,33. No entanto, informa que não possui recursos para continuar custeando o tratamento, o que coloca em risco sua qualidade de vida

e sobrevivência, pois não há alternativa terapêutica disponível.

Tece argumentação jurídica e requer a concessão da tutela antecipada de urgência, tendo em vista estarem comprovados os seus requisitos legais, determinando-se que a ré garanta o tratamento da autora, mediante o fornecimento/custeio da droga KIENDRA® (SIPONIMODE), desde que mediante prescrição da médica e até a alta médica definitiva, impondo ainda, que o cumprimento da liminar ocorra no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de multa diária.

No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência para condenar a ré a autorizar e custear da terapia com o medicamento Kiendra® (Siponimode), conforme prescrição do médico assistente e até a alta médica definitiva, bem como o reembolso do valor das primeiras aplicações do medicamento Kiendra, no importe de R$ 36.851,33 (trinta e seis mil oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos), dando-se efetivo cumprimento ao contrato entabulado entre as partes, declarando-se a abusividade e ilegalidade da negativa ofertada pela ré.

A decisão de ID 210018626 deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré procedesse ao fornecimento do medicamento Kiendra® (Siponimode), conforme prescrição médica (ID 210017347), no prazo de 05 dias, contados da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 20.000,00.

Contestação (ID 212654310). Afirma ser uma operadora de saúde de autogestão, entendendo a inaplicabilidade do CDC. Argumenta que não é obrigada a cobrir o medicamento Kiendra® (Siponimode) prescrito para a autora, em razão de o medicamento não estar incluso no rol da ANS, nem possuir respaldo de evidências científicas ou recomendações de órgãos renomados. Destaca que a cobertura do medicamento não faz parte das obrigações contratuais e requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Foi comunicada a interposição de agravo do instrumento n. 0741250-63.2024.8.07.0000, o qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão de ID 210018626.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. **DECIDO.**

II. FUNDAMENTAÇÃO

Do julgamento antecipado

O processo tem julgamento antecipado, uma vez que a questão suscitada no presente processo é prevalentemente de direito, o que atrai o disposto no art. 355, inciso I, do CPC. Nesse caso, o julgamento do processo no estado em que se encontra é medida que se impõe, não se fazendo necessária a dilação probatória.

Da relação existente entre as partes

A relação existente entre as partes é regida pela Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não sendo o caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC, porquanto se trata de plano de saúde de autogestão, uma vez que, conforme súmula 608 do STJ, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Cinge-se a lide acerca da possibilidade de o réu, seguro de saúde contratado pela autora, custear integralmente o medicamento Kiendra® (Siponimode), além do reembolso pelos valores já gastos com o medicamento.

A autora informa que foi diagnosticada com esclerose múltipla progressiva secundária em 1999; que fez uso de diversos medicamentos, incluindo imunomoduladores e corticoides; que o quadro clínico vem se agravando, com novos surtos e aumento das lesões cerebrais; que a médica responsável prescreveu o medicamento Kiendra (Siponimode), sendo, contudo, negada a autorização para o custeio pela ré.

Por sua vez, o requerido alega que o medicamento solicitado se encontra fora das diretrizes de utilização da ANS; que a cobertura do medicamento não faz parte das obrigações contratuais; e que não possui respaldo de evidências científicas ou recomendações de órgãos renomados.

Do caráter do rol da ANS

A Segunda Seção do c. STJ, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, no entanto, a existência de situações excepcionas capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos no rol, *in verbis*:

> Proclamação Final de Julgamento: (...) estabeleceu a tese quanto à taxatividade, em regra, nos seguintes termos: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - <u>não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente</u>, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) <u>haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências</u>; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. No caso concreto, a Segunda Seção, por unanimidade, negou provimento aos

> embargos de divergência, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator." (Segunda Seção, EREsp nº 1886929/SP, Relator: Min. Luís Felipe Salomão, Data do Julgamento: 8/6/2022).

As peculiaridades do caso concreto enquadram os planos de saúde nas situações excepcionais estabelecidas no precedente qualificado, restando justificada a necessidade de realização do tratamento solicitado pelo médico especialista, considerando as peculiaridades, gravidade e avançado estágio da doença que acomete a parte autora.

Nesse caso, o julgador pode determinar que o seguro contratado arque com as despesas decorrentes do procedimento, ainda que não previsto no rol da ANS.

Outrossim, consoante art. 2º da RN n. 465/2021, da ANS, a superveniência da lei n. 14.454/2022 pacificou tal controvérsia, tendo em vista que assentou a natureza exemplificativa do referido rol da ANS, alterando o disposto na lei n. 9.656/98, nos §§ 12 e 13 de seu art. 10, o qual passou a constar nos seguintes termos:

> Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...)
>
> § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a **referência básica** para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.
>
> § 13. **Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser**

> autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:
>
> I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou
>
> II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."

No mesmo sentido da natureza exemplificativa do rol da ANS, veja-se o previsto na Lei 9.361/00, que criou a ANS, no inciso III do art. 4º:

> Art. 4º Compete à ANS:
>
> III - elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão **referência básica** para os fins do disposto na Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9656.htm), e suas excepcionalidades.

Como se vê, o dispositivo supracitado prevê que o rol da ANS constitui referência básica, de modo que os procedimentos lá previstos são de cobertura mínima obrigatória, não excluindo outros que lá não estão previstos, do que se conclui que possui realmente natureza exemplificativa.

Ademais, o rol da ANS é atualizado a cada dois anos, não se podendo exigir do usuário que, quando da adesão ao plano de saúde, anteveja os procedimentos que serão objeto de cobertura quando de sua necessidade de saúde.

O usuário, ao aderir a plano de saúde, tem a legítima expectativa de que, em caso de necessidade, será amparado pelo plano de saúde, de forma a obter os tratamentos, exames e medicamentos que se fizerem necessários, nos limites da cobertura prevista para o plano.

Diante disso, é inegável a natureza exemplificativa do rol da ANS, de modo que eventual ausência de previsão no rol da ANS não exclui, por si só, a obrigatoriedade da cobertura.

Do tratamento prescrito

Analisando o conjunto probatório, a autora comprova ser portadora de esclerose múltipla desde 1999 (ID 210017347).

Nos termos do laudo médico particular (ID 210017347) a autora já realizou diversos tratamentos em busca de estabilidade de seu quadro clínico, entretanto, está evoluindo com piora progressiva do quadro, vejamos:

> Declaro que a paciente LAVINIA MARIA MAIA DE LEMOS, 55 anos, leucoderma, solteira, é portadora de esclerose múltipla em tratamento neurológico comigo desde 1999.
>
> O paciente iniciou o tratamento com Rebif e a pós um período de um ano, foi substituída a medicação para Acetato de Glatirâmer diário em razão de surtos.
>
> **Em 2004 realizou pulsoterapia e Imuran, apresentou novo surto com incontinência urinária e aumento das parestesias em membro inferior esquerdo. RNM de craneo da época mostrou aumento difuso das dimensões das lesões em coluna cervical. Deste surto evoluiu com seqüela no dorso flexão do pé direito. EDSS 2.5 (Escala Expandida do Estado de Incapacidade). Trocado medicação para Betaferon 9.600.000, mantinha o mesmo EDSS de 2.5 sendo que todos os exames de imagem realizados no período a época não mostraram lesões captantes ou aumento do número de T2.**
>
> **Paciente evoluindo com piora progressiva do quadro, apresentou novos surtos com aumento do déficit motor em membros inferiores**. O exame neurológico apresentou hipopalestesia em membros inferiores maior a direita com piora do equilíbrio e Romberg com retro e lateropulsão, paraparesia grau III/V. RNM de crânio de 24.05.2012 mostrou lesão no centro semioval a esquerda captando gadolíneo. RNM de coluna cervical sem lesões captantes. Realizado pulsoterapia com Solumedrol. EDSS 4.5.

Em razão da piora progressiva o paciente iniciou Natalizumab, com boa resposta até a 6ª dose, quando o quadro estacionou. Aproximadamente 10 meses do tratamento a paciente evoluiu com piora do quadro, apresentando surtos, caracterizando Falha Terapêutica, EDSS 6.0 atualmente.

Paciente fez uso de Fingolimode (nome comercial: Gilenya) durante aproximadamente 06 anos, porém, apresentou quadro de piora de déficit motor em MMSS, que estavam preservados.

Em razão da idade da paciente (52 anos à época), de manter-se ativa, com a possibilidade de utilização dos MMSS e cognição preservada, opto pela troca de Fingolimode para Ocrelizumabe.

Paciente fez uso da medicação apresentando estabilidade do quadro.

O ano de 2020, em razão da pandemia, a medicação foi suspensa, pelo risco ainda não sabido e de não haver propedêutica para evitar a infecção.

Diante do quadro atual e da piora clinica pela falta de medicação para a doença de base (G-35), optamos (paciente de comum acordo com médica assistente), retornar o tratamento com Ocrelizumabe

Paciente realizou infusão de 4º dose de Ocrelizumabe em março de 2022, tendo apresentado reações adversas muito fortes que deixaram a paciente restrita ao leito, o que foi melhorando com o decorrer das semanas.

Trata-se, pelo relato de efeito colateral à droga, o que indica a troca de medicação.

Paciente encontra-se há mais de um ano sem medicação, fazendo apenas tratamento de surtos, evoluindo com piora do quadro clínico.

Oriento o uso de Kiendra (oral), medicação para forma Secundariamente Progressiva da patologia G-35, o que diminui o risco de efeito adverso prolongado, em razão da rapidez de ação, da meia vida, e da facilidade de uso.

Ratifico que tal medicação é realizada de forma domiciliar diário.

O tratamento é iniciado com liberação de dosagem, após teste de genotipagem. Tendo a paciente já feito a genotipagem estando liberada para o uso da medicação.

Importante salientar que o juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz medicamento e tratamento de saúde cabe tão somente ao médico, profissional capacitado, que indica, baseado no histórico clínico de cada um de seus pacientes e em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento clínico.

Ademais, junto à exordial foram acostados o registro na ANVISA do medicamento (ID 210017350) e o parecer NATJUS (ID 210017352), em que se concluiu pela eficácia dos medicamentos. Além do relatório da médica da autora que atesta o sucesso do medicamento para o tratamento da doença que acomete a requerente.

Outrossim, considerando que a patologia que acomete a parte autora é coberta pelo contrato de plano de saúde e, ainda, que o medicamento é comprovadamente eficaz e com " *recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias"* (lei nº 9.656/98, art. 10, §13), pode haver a cobertura, a título excepcional, do tratamento indicado pela médica assistente.

Desse modo, considerando a relevância do tratamento e a eficácia do medicamento indicado pela médica responsável, é injustificável a recusa de cobertura contratual de fornecimento da medicação necessária ao tratamento, sob o argumento de que o medicamento solicitado não consta na relação de medicamentos previstos na Resolução Normativa nº 387, da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Nesse sentido seguem os precedentes deste TJDFT e do STJ:

> CIVIL E CONSTITUCIONAL. DOIS APELOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ESCLEROSE MÚLTIPLA. SIPONIMODE/ KIENDRA. FAMPRIDINA/FAMPYRA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. FUNDAMENTAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FÁRMACOS ESPECÍFICOS PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA. REGISTRADO NA ANVISA. EFICÁCIA COMPROVADA. LEI N° 9.656/98, ART. 10, § 13. RECUSA DO TRATAMENTO.

INDEVIDA. AMBOS OS RECURSOS SEM SUCESSO. MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. APELO DA AUTORA. NÃO CONHECIDO. APELO DA RÉ. IMPROVIDO.

(...)

4. Do mérito. 4.1. O direito à saúde é elevado ao patamar de fundamental, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1°, inciso III, do art. 6º e do art. 196, todos da Constituição Federal. Inspirado nesse princípio e concretizando o emprego dos direitos e garantias fundamentais, no setor do direito privado, editou-se a Lei n.º 9.656/98, a qual dispõe acerca dos planos e seguros privados de assistência à saúde. 4.2. Sobre o tema, a Lei 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/98: "Art. 10, § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." 4.3. A legislação reconhece, a título excepcional, a possibilidade de cobertura de tratamento não constante no rol da ANS.

5. No caso específico dos autos, de acordo com os relatórios médicos, a autora é portadora de esclerose múltipla (CID G35) há vários anos, com grande nível de incapacidade, diante disso, o médico neurologista indicou o início imediato do tratamento com Fampridina e com Siponimode. 5.1. Junto à exordial foram acostados o registro na ANVISA de ambos os medicamentos e o parecer NATJUS, em que se concluiu pela eficácia dos medicamentos. Além dos relatórios dos médicos da autora que atestam o sucesso dos medicamentos para o tratamento da doença que acomete a requerente. 5.2. **Tratando-se de patologia coberta pelo contrato de plano de saúde, comprovada a eficácia dos medicamentos, bem como "recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias" (Lei nº 9.656/98, Art. 10, §13), pode haver a cobertura, a título excepcional, do tratamento indicado pelo médico.**

6. TJDFT: “(...) II. A Lei 14.454/2022 alterou a Lei 9.656/1998 para estabelecer os critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, determinando a autorização de cobertura na hipótese em que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. III. Evidenciado que, no caso concreto, o tratamento realizado com órtese craniana é a alternativa terapêutica para o paciente acometido com Braquicefalia e Plagiocefalia posicional severa, por consequência resulta cristalina a obrigação do plano de saúde em arcar com o custeio da cobertura do tratamento, o qual, aliás, pode evitar futuro procedimento cirúrgico de maior complexidade e altos custos (...)” (07016461720238070005, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2ª Turma Cível, PJe: 7/3/2024). 6.1 “(...) 1. "Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário" (AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 20/4/2023).

7. A eficácia dos fármacos é irrefutável, porquanto possuem registro ativo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, bem como são indicados para o tratamento de pacientes com esclerose múltipla. A recusa da apelante em custear a cobertura dos medicamentos, registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e prescritos pelo médico da apelada, se mostra abusiva.

(...)

9. Recurso da autora não conhecido. 9.1. Recurso da ré improvido.

(Acórdão 1880736, 0735532-19.2023.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 03/07/2024.)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. ÓRTESE CRANIANA. FORA DE PROPORÇÃO A NEGATIVA DE COBERTURA. DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES COM

TRATAMENTO. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL: DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A autonomia da vontade não pode se sobrepor aos valores da boa-fé e função social do contrato de plano de saúde (Código Civil, art. 421), atrelado que está à preservação da dignidade do indivíduo (parte consumidora dos serviços de saúde). Portanto, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6º e 14 c/c entendimento sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça) e da Lei 9.656/1998. II. **A Lei 14.454/2022 alterou a Lei 9.656/1998 para estabelecer os critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, determinando a autorização de cobertura na hipótese em que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. III. Evidenciado que, no caso concreto, o tratamento realizado com órtese craniana é a alternativa terapêutica para o paciente acometido com Braquicefalia e Plagiocefalia posicional severa, por consequência resulta cristalina a obrigação do plano de saúde em arcar com o custeio da cobertura do tratamento**, o qual, aliás, pode evitar futuro procedimento cirúrgico de maior complexidade e altos custos (...)" (07016461720238070005, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2ª Turma Cível, PJe: 7/3/2024).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. **ESCLEROSE MÚLTIPLA** REMITENTE. PACIENTE MENOR DE IDADE. MEDICAMENTO. USO OFF-LABEL. REGISTRO NA ANVISA. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "**Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente**, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, **especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário**" (AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

Indevida, portanto, a negativa de cobertura, que configura o inadimplemento contratual, razão pela qual é cabível a condenação da ré na obrigação de custear o tratamento indicado pela médica assistente da parte autora.

Do pedido de reembolso

Demonstrado o ato ilícito da operadora do plano de saúde e a falha na prestação de seu serviço, configurada pela negativa de cobertura a procedimento de cobertura obrigatória, bem como o dano material decorrente da conduta da ré causado à parte autora, que teve de desembolsar os valores necessários para o custeio do tratamento requerido, restam configurados os requisitos da responsabilidade civil, de modo que o pedido de reparação material deve ser acolhido.

Compulsando os autos, verifico que a autora juntou notas fiscais nos valores de R$ 4.390,01, na data de 17/01/2024; R$ 4.390,01, na data de 14/02/2024; R$ 7.048,77, na data de 15/04/2024; R$ 13.973,77, na data de 10/05/2024; R$ 7.048,77, na data de 12/07/2024 (ID 210017349).

Diante disso, o ressarcimento deve ocorrer no valor de R$ 36.851,33 (trinta e seis mil oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês desde a data de cada desembolso.

Nesse passo, o acolhimento dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

III. DISPOSITIVO

Forte nessas razões, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos da parte autora, para **CONFIRMAR** a tutela de urgência concedida sob ID 210018626, a qual determinou que a ré custeasse o tratamento da autora, nos moldes do relatório médico e prescrição e, ainda, **CONDENAR** a ré a reembolsar a parte autora, a título de ressarcimento das despesas médicas, o valor de R$

36.851,33 (trinta e seis mil oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês desde a data de cada desembolso.

Resolvo o mérito da demanda, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Comunique-se ao desembargador relator do agravo de instrumento n. 0741250-63.2024.8.07.0000 acerca da presente sentença.

Transitada em julgado, e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.

BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2024.

GEILZA FÁTIMA CAVALCANTI DINIZ

Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: GEILZA FÁTIMA CAVALCANTI DINIZ
04/11/2024 18:27:37
https://pje.tjdft.jus.br/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

24110418273677900001971

IMPRIMIR GERAR PDF